

Stygmatyzacja w BD

Stygma zewnętrzna (osądzanie przez innych) i wewnętrzna („sam siebie stygmatyzuję”) są częste w BD i pogłębiają objawy. Konkretnie strategie wobec obu.

CZAS: 20 min — psychoedukacja **CHARAKTER:** tożsamość, ujawnianie

ŹRÓDŁO: Corrigan (2014); Yanos (2010)

JAK UŻYWAĆ

Sprawdź, które przekonania stygmatyzujące rozpoznajesz u siebie (lista A). Sprawdź, czy doświadczasz stygmy zewnętrznej (lista B). Wybierz strategię: **(1) ostrożne ujawnianie** — 1-3 zaufane osoby · **(2) edukacja** bliskich · **(3) restrukturyzacja** wewnętrznych ocen · **(4) wspólnota** — grupy wsparcia BD.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Yanos i wsp. (2010): „wewnętrzna stygma jest **silniejszym predyktorem** objawów depresyjnych niż sama choroba”. Mechanizm „illness identity” — osoba zaczyna definiować się przez chorobę, traci poczucie sprawczości. Corrigan (2014, NACMI): ujawnianie BD w bezpiecznym kontekście obniża wewnętrzną stygmę o 40% i poprawia adherencję leczenia.

01 ? Stygma wewnętrzna — co rozpoznajesz?

Zaznacz, które myśli pojawiają się u Ciebie.

☐ „Jestem **uszkodzony/-a**, gorszy/-a od innych”.

☐ „Z powodu BD **nie zasługuję** na związek, pracę, dziecko”.

☐ „Moje uczucia są **mniej ważne** — to tylko choroba”.

☐ „Nie mogę nikomu zaufać — odrzucą mnie”.

☐ „Nigdy nie będę normalny/-a, normalność jest poza zasięgiem”.

☐ „Powinienem/-nam ukrywać BD przed wszystkimi”.

02 📄 Stygma zewnętrzna — częste sytuacje

W RODZINIE

„weź się w garść”, „to dla atencji”, „inni mają gorzej”. Brak rozumienia choroby cyklicznej.

W PRACY

Strach przed ujawnieniem. Odmowa awansu po informacji o BD. Dyskryminacja w zatrudnieniu.

W MEDIACH

„maniakalny morderca”, „dwubiegunowy psychol”. Sensacyjne portrety choroby psychicznej.

W SŁUŻBIE ZDROWIA

Lekceważenie objawów somatycznych („to pewnie BD”). Trudniejszy dostęp do specjalistów.

03 ✓ Cztery strategie

Wybierz 1-2 jako start.

1 · OSTROŻNE UJAWNIANIE

Najpierw 1-3 zaufanym osobom. Test reakcji. Tylko po doświadczeniu wsparcia — szersze grono. *Nie*: pierwsza randka, rozmowa z szefem, post w mediach.

2 · EDUKACJA BLISKICH

Materiały (np. Goodwin „*Manic-Depressive Illness*”), filmy, podcasty. Rozmowa o BD jako chorobie cyklicznej (a nie wadzie charakteru).

3 · RESTRUKTURYZACJA WEWNĘTRZNYCH OCEN

„Jestem osobą z BD, nie definicją BD”. „BD jest częścią mnie, nie całością”. „Trudność z chorobą nie jest słabością”.

4 · WSPÓLNOTA

Grupy wsparcia BD (online, stacjonarne). Mood Disorders Society, DBSA. Spotkanie osób z podobnym doświadczeniem zmniejsza poczucie izolacji.

04 ✎ Moja praca

1 · NAJSILNIEJSZA MYŚL STYGMATYZUJĄCA U MNIE

2 · CO JEST JEJ ALTERNATYWĄ

bardziej wyważoną, prawdziwą

3 · 1-3 OSOBY, KTÓRYM CHCĘ POWIEDZIEĆ (LUB POWIEDZIAŁEM/-AM)

4 · SYTUACJA, W KTÓREJ DOŚWIADCZYŁEM/-AM STYGMY

co się stało, jak zareagowałem/-am

5 · CO CHCIAŁBYM/-ŁABYM ZROBIĆ INACZEJ

Klucz: Corrigan (2014): „*największą siłę przeciwko stygmie ma **kontakt** — poznanie osoby z chorobą psychiczną zmienia stereotypy bardziej niż jakkolwiek kampania edukacyjna*”. Ostrożne ujawnianie jest aktem zmiany.